天天师兄 展示 2017-2026 年临床医学综合能力（306）的“内科学含诊断学”出题规律				
共 51 题 （100 分）	A_1 （41-56 题）	A_2 （68-92 题）	B （128-131 题）	X （154-159 题）
诊断	1-2	5（3+2）		
呼吸	3-4	3	0-2	1
循环	3-4	3	0-2	1
消化	3	3	2（多为中毒）	1（可为中毒）
泌尿	1	3		1
血液	1	3		1
内分泌	1	3		1
风湿	1-2	2		

病例题是关键
抓住疾病主要特点

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

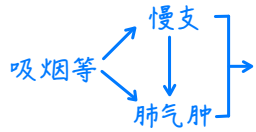
考频（8-12 题，★★★）：A_1 3-5　A_2 3-6　B 0-2　X 1

病理学:慢支炎、肺气肿

①阻塞性通气功能障碍（气流受限性疾病）：慢性阻塞性肺疾病 COPD、支气管哮喘、支气管扩张症
②限制性通气功能障碍：间质性肺疾病（特发性肺间质纤维化、结节病、过敏性肺炎等）、胸膜疾病（胸腔积液、气胸）（内科+外科）、急性呼吸窘迫综合征 ARDS
③肺动脉高压：特发性肺动脉高压、急性肺血栓栓塞症（急性肺心病）、慢性肺源性心脏病（COPD 等导致）
④感染：肺炎和肺脓肿、肺结核
⑤肿瘤：原发性支气管肺癌（内科+外科）
⑥呼吸衰竭：上述疾病进展可导致

无持续气流受限 ┬ 慢支炎:咳、痰、喘 症状每年至少持续3个月,连续2年以上
　　└ 肺气肿:RV/TLC>40%
↓ 肺实质不断破坏
持续气流受限　COPD:FEV1/FVC<70%

注意：先复习《病理学》呼吸系统疾病相关章节，再复习内科学，并回顾式串联《生理学》



核心精讲·慢性阻塞性肺疾病 COPD

COPD(持续气流受限)（性感认识：持续气流受限）VS 支气管哮喘:可逆的气流受限

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

生理学可以将肺气肿等同于COPD,内科学不行

一、COPD 的临床表现

1.标志性症状是气短，常在活动后出现 活动加重氧耗

复习《生理学》：肺的弹性阻力始终是吸气的阻力、呼气的动力。中性粒细胞的活化和聚集是 COPD 炎症过程的重要环节：吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶→破坏肺的弹性成分（肺弹性阻力减小）→肺气肿→COPD（呼气性呼吸困难）

肺的弹性阻力始终使肺组织回缩:①肺泡表面张力②肺组织本身弹性成分的回缩力

2.COPD 由慢支炎发展而来，因此 COPD 有慢支炎的表现——咳、痰、喘 3+2
①稳定期：主要咯白色泡沫痰
②急性加重期：主要咯黄脓痰 最主要的原因:感染



“可能可能最可能”：**中老年、长期咳痰喘、吸烟→首先考虑 COPD**

快速切入点,提取关键信息　优先考虑,但不一定是这种情况